



ОРЕКСИНОВАЯ СИСТЕМА ПРИ ОСТРОЙ МАНИИ

10.05.2026 / **Новости**





значительно хуже работают как практические инструменты. Особенно это касается мании. Её клиническая картина выглядит очень узнаваемой, но механизмы, которые запускают и поддерживают маниакальный эпизод, до сих пор описаны неполно. На этом фоне интерес к орексиновой системе выглядит вполне закономерным. Орексины регулируют цикл сон-бодрствование, энергетический обмен и обработку вознаграждения, то есть именно те домены, которые клинически искажаются при мании.

Орексин-А и орексин-В синтезируются в латеральном гипоталамусе и действуют через два рецептора, OX1R и OX2R. Через связи с моноаминергическими системами орексиновая сеть влияет на дофаминергическую, серотонинергическую и норадренергическую нейротрансмиссию, а значит, теоретически может быть встроена в нейробиологию биполярного расстройства сразу на нескольких уровнях. При этом, как подчёркивают авторы исследования, данных по орексиновой системе именно при маниакальным состояниям до сих пор было мало, а периферические уровни орексиновых рецепторов у таких пациентов фактически не изучались.

В работу включили 30 стационарных пациентов с биполярным расстройством I типа в текущем маниакальном эпизоде и 30 социодемографически сопоставимых здоровых добровольцев. Все пациенты на момент включения ещё не начали лечение, что особенно важно для интерпретации биомаркеров. Концентрации орексина-А, орексина-В, растворимого рецептора орексина-1 и растворимого рецептора орексина-2 измеряли в сыворотке натощак с помощью ELISA. Тяжесть мании оценивали по шкале Young Mania Rating Scale. Дальше авторы провели межгрупповые сравнения, корреляционный анализ, ROC-анализ и сетевой анализ взаимосвязей между компонентами орексиновой системы.

Результаты исследования продемонстрировали, что уровни OXA, OXB, sOX1R и sOX2R были статистически значимо ниже в группе острой мании, причём для всех четырёх показателей различия имели уровень значимости $p < 0,001$. То есть сигнал затрагивал не один изолированный маркер, а всю периферическую орексиновую систему.

Отдельный интерес представляют связи с клиническими характеристиками. Уровень орексина-А отрицательно коррелировал с длительностью текущего маниакального эпизода и был связан с симптомом сниженной потребности во сне. Повышенный сексуальный интерес ассоциировался с более высоким уровнем sOX2R. Эти данные указывают на то, что орексиновая система может быть ближе





выглядит как состояние не только со снижением отдельных уровней, но и с нарушением согласованности работы всей орексиновой системы.

Разведочный ROC-анализ выявил, что все четыре показателя орексиновой системы довольно хорошо отличали пациентов с острой манией от здоровых участников. Лучший результат дал растворимый рецептор sOX1R. Это означает, что такие маркеры потенциально могут быть полезны для различения групп на исследовательском уровне. Однако говорить о готовом диагностическом тесте пока рано: выборка слишком маленькая, а результаты нужно проверять в более крупных и независимых исследованиях.

Почему это важно

Мания давно описывается через дофамин, циркадные нарушения, системы вознаграждения и автономную активацию. Орексиновая система связывает все эти домены в единую физиологическую рамку. Поэтому сам факт, что при острой мании снижены и пептиды, и растворимые рецепторы, а внутренняя согласованность системы ослаблена, выглядит биологически правдоподобно и клинически небезынтересно. Это не объясняет манию целиком, но добавляет ещё один возможный уровень её механистического описания.

Что это меняет

Эта статья хорошо иллюстрирует более общий сдвиг в психиатрии. Речь всё чаще идёт не о поиске одного «волшебного» маркера, а о реконструкции целых биологических сетей, которые могут быть нарушены при конкретном состоянии. В таком контексте орексиновая система интересна сразу в двух плоскостях. С одной стороны, как возможный источник периферических маркеров. С другой стороны, как потенциальная терапевтическая мишень, тем более что интерес к орексиновым рецепторам в психофармакологии уже существует. Но путь от такой статьи до клинического теста или нового лечения остаётся длинным.

Ссылка на исследование

Erdogan EC, Ugurlu M, Kabadayi Sahin E, Kamis GZ, Uzdogan EA, Karakas Ugurlu G. Peripheral orexin system alterations in acute bipolar mania: Associations with clinical



врачи



О Пин

